WIRKUNGSÖKONOMIE

Gesundheit & Pflege

Umfangreiche Einzeldossiers - Korrekturfassung v0.3

Von der Krankheitsfinanzierung zur Wirkungsgesundheit

Stand: 2. August 2026 · Autorin: Natalie Weber · Öffentliche Lesefassung

Fachliche Einordnung: Diese Korrekturfassung trennt die monetäre Bilanz von nichtmonetären Zustandsveränderungen. Die frühere PDF v0.2 bleibt als historische Quellenfassung unverändert erreichbar. Für T-SROI gilt der aktuelle Rechenstandard v1.1 mit Quellenarchiv WÖK-Q-1024.

Kurz erklärt

Wenn man wissen will, ob ein Programm Geld spart, rechnet man Euro mit Euro. Wenn man wissen will, ob Menschen selbstständiger leben, teilhaben oder besser mit Krisen zurechtkommen, misst man diese Veränderungen in ihren eigenen Einheiten. Beides ist wichtig. Beides darf nicht künstlich zu einer Zahl zusammengeklebt werden.

Die Rechnung hat deshalb zwei sichtbare Teile: einen diskontierten Geldsaldo und ein nichtmonetäres Wirkungsprofil. Eine positive Geldbilanz genügt nicht: Rote Linien, schwere Verschlechterungen, fehlende Vergleichsfälle oder zu schwache Daten blockieren die Aussage über positive Netto-Wirkung.

Vereinfachte Beispielrechnung: zwei Bilanzen, keine Mischzahl

Modellwert, keine Prognose und keine medizinische Einzelfallentscheidung.

Annahmen: Preisbasis 2026, Betrachtungszeitraum ein Jahr. Die Maßnahme kostet zum Startzeitpunkt t = 0 200.000 EUR. Für t = 1 werden gegenüber einem dokumentierten Vergleichsfall 150.000 EUR Behandlungskosten und 90.000 EUR Pflegekosten vermieden; 20.000 EUR belegte Nebenwirkungs- und Verlagerungskosten bleiben im Abzug. Alle Geldwerte sind real in EUR 2026. Der Diskontsatz beträgt r = 3 %. Nicht ausreichend zurechenbare oder nicht belastbar monetarisierte Beträge werden nicht angesetzt.

Monetäre Bilanz: B_EUR = -200.000 + (150.000 + 90.000 - 20.000) / 1,03 = +13.592,23 EUR (gerundet +13.592 EUR). Das ist ein diskontierter Modell-Geldsaldo, nicht der Wert eines Menschen und nicht der Beweis für positive Netto-Wirkung.

Nichtmonetäres Wirkungsprofil: Der Anteil der Teilnehmenden mit einem zeitnahen Versorgungszugang steigt gegenüber dem Vergleichsfall von 52 % auf 60 %; Δ Zugang = +8 Prozentpunkte. Die 1.000 erreichten Personen sind nur Reichweite. Wirkung ist die gemessene Zustandsveränderung von +8 Prozentpunkten, mit Quelle, Vergleichsfall, Zeitraum, Attribution und Unsicherheit. Diese +8 Prozentpunkte werden weder in EUR umgerechnet noch mit dem Geldsaldo verrechnet.

Schutz-Gate: Wird eine rote Linie, eine schwere Verschlechterung oder eine unvertretbare Datenlücke festgestellt, lautet das Ergebnis trotz des positiven Geldsaldos "blockiert / nicht bewertbar". Ein vermiedener Geldbetrag kompensiert keinen Gesundheitsschaden, keine Diskriminierung und keine Rechtsverletzung.

Gesundheit als gesellschaftliches Wirkungsfeld

Gesundheit entsteht in Lebensbedingungen, Versorgung, Arbeit, Wohnen, Ernährung, Bildung, Kultur, Umwelt, digitaler Öffentlichkeit und Vertrauen. Dieses Detailkonzept begründet Gesundheit als gesamtgesellschaftliche Wirkungsinfrastruktur.

1. Zielbild und Abgrenzung

Das Ziel ist nicht eine perfekt gesunde Normgesellschaft. Krankheit, Behinderung, Alter, Verletzlichkeit und Unterschiedlichkeit gehören zur menschlichen Wirklichkeit. Das Ziel ist ein System, das vermeidbare Gesundheitsrisiken reduziert, Zugang sichert, Würde schützt und positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie erzeugt.

2. Problem der alten Logik

Die alte Logik arbeitet reaktiv. Sie finanziert sichtbar gewordene Schäden, behandelt Einzelpersonen und trennt Ressorts, obwohl Ursachen oft außerhalb medizinischer Versorgung liegen. Dadurch entstehen Reparaturkosten, die in Haushalten sichtbar sind, während vermiedene Krankheit unsichtbar bleibt.

3. Wirkungsökonomischer Perspektivwechsel

Die Wirkungsökonomie fragt nach Zustandsveränderungen. Sie unterscheidet Behandlung, Prävention, Stabilisierung, Teilhabe, Autonomie und Resilienz. Ein Gesundheitsprogramm ist nicht erfolgreich, weil es viele Leistungen abrechnet, sondern weil es Gesundheitsrisiken senkt, Selbstständigkeit erhält, Versorgung verbessert und Vertrauen stärkt.

4. Wirkungspfade

Direkte Wirkung: bessere Versorgung, weniger Symptome, weniger Komplikationen, schnellere Hilfe.

Indirekte Wirkung: weniger Pflegebedarf, weniger Arbeitsausfälle, weniger Familienüberlastung, mehr Teilhabe.

Systemische Wirkung: weniger Reparaturkosten, höhere Resilienz, mehr Vertrauen, geringere Krisenanfälligkeit.

Demokratische Wirkung: Menschen erleben handlungsfähige Institutionen und gerechte Zugänge.

5. Indikatoren und WÖk-ID-Anschluss

Arbeits- und Gesundheitsschutz

psychosoziale Risiken

Lokale Emissionen NOx/PM/SOx

Gesunde Gebäude und Innenraumluft

Lärm-Exposition

Stadtgrün/Naturzugang

Produktsicherheit und Rückrufe

6. Datenquellen und Datenqualität

Datenart

Beispiel

Schutzanforderung

Strukturdaten

Versorgungsdichte, Wartezeiten, Pflegekapazität

keine personenbezogene Sanktionierung

Sozialraumdaten

Hitze, Lärm, Grün, Armut, Einsamkeitsrisiko

kommunale Transparenz und Kontext

Versorgungsdaten

Wiederaufnahmen, Prävention, Patientensicherheit

Zweckbindung, Datenschutz, Pseudonymisierung

Qualitative Daten

Würde, Autonomie, Belastung, Vertrauen

freiwillig, nicht diskriminierend

7. Berechnungs- und Bewertungslogik

Bewertung erfolgt mehrdimensional: Gesundheitsgewinn, vermiedener Schaden, Resilienz, Teilhabe, Gerechtigkeit, Datenqualität und Nebenwirkungen. Monetarisierung ist möglich, aber nicht allein entscheidend. Nicht alles, was zählt, lässt sich sofort in Euro ausdrücken; trotzdem muss es sichtbar bleiben.

8. Politische Umsetzungsoptionen

Politik kann verschiedene Wege wählen: gesetzliche Garantie, Kassenfinanzierung, kommunale Gesundheitsfonds, Modellregionen, öffentliche Beschaffung, Arbeitgeberpflichten oder Förderprogramme. Entscheidend ist nicht die eine Ideologie, sondern die Korrigierbarkeit und Überprüfbarkeit der Wirkung.

9. Grenzen und Missbrauchsschutz

Gesundheitswirkung darf nie zum Menschenranking werden. Bewertet werden Räume, Programme und Strukturen. Schutzgrenzen sind: keine Schuldlogik gegen Kranke, keine Diskriminierung, keine heimliche Gesundheitsüberwachung, kein Zugriff auf individuelle Gesundheitsdaten ohne Rechtsgrundlage und keine Verengung auf Selbstoptimierung.

11. Konkretes Beispiel

Beispielhaft wird ein Pilot mit 50.000 Einwohner:innen betrachtet. Ausgangsdaten: Gesundheitsausgaben, Pflegebedarf, Altersstruktur, Hitze- und Lärmbelastung, Versorgungszugang, Wartezeiten, soziale Lage und subjektive Belastung. Interventionen: Gesundheitslots:innen, Präventionsbudget, Pflegeentlastung, Sozialraumverbesserung und digitale Unterstützung. Die jährliche Evaluation misst nicht nur Leistungsmengen, sondern Zustandsveränderungen.

12. Rechenlogik für das Dossier

Zwei Bilanzen statt einer Mischrechnung: Euro gehören zu Euro. Lebensqualität, Autonomie, Teilhabe und Resilienz behalten ihre eigenen Einheiten. Beides zählt, wird aber nicht zu einer Zahl vermischt.

```
Monetäre Bilanz (EUR, Preisbasis und Zeitraum offenlegen): B_EUR = Summe_t [(vermiedene
Behandlungskosten_t + vermiedene Pflegekosten_t + monetarisierte Arbeitsausfälle_t + sonstige
dokumentiert monetarisierte Nutzen_t - Programmkosten_t - monetarisierte Nebenwirkungs- und
Verlagerungskosten_t) / (1 + r)^t]. Jeder Term ist Euro desselben Preisjahrs; r ist der
dokumentierte Diskontsatz. Fehlt eine belastbare Monetarisierung, darf der Term nicht in B_EUR
stehen.
```

Nichtmonetäres Wirkungsprofil: Für Gesundheitszustand, Autonomie, Teilhabe, Resilienz, Gerechtigkeit und mögliche Schäden wird je Indikator die Veränderung gegenüber dem Vergleichsfall ausgewiesen: Δx_k = x_k,mit Maßnahme - x_k,ohne Maßnahme. Jede Angabe braucht Einheit, Zeitraum, Quelle, Vergleichsfall, Attribution und Unsicherheit. Diese Veränderungen werden nicht in Euro umgerechnet und nicht zu einem Durchschnitt verrechnet.

Entscheidungsregel: Eine positive monetäre Bilanz ist kein Freifahrtschein. Eine positive Netto-Wirkung wird nur ausgewiesen, wenn Wirkungsgrenze, Vergleichsfall und Datenqualität offenliegen, keine rote Linie verletzt wird und das Wirkungsprofil keine schwere Verschlechterung verdeckt. Alle Angaben bleiben Quelle, Schätzung oder Modellwert.

Prävention, Gesundheitskassen und Wirkungshaushalt

Prävention wird zur ersten Wirkleistung. Vermiedene Schäden, längere Autonomie, weniger Pflegebedarf und geringere Krisenlast werden sichtbar und haushaltsfähig.

1. Zielbild und Abgrenzung

Das Ziel ist nicht eine perfekt gesunde Normgesellschaft. Krankheit, Behinderung, Alter, Verletzlichkeit und Unterschiedlichkeit gehören zur menschlichen Wirklichkeit. Das Ziel ist ein System, das vermeidbare Gesundheitsrisiken reduziert, Zugang sichert, Würde schützt und positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie erzeugt.

2. Problem der alten Logik

Die alte Logik arbeitet reaktiv. Sie finanziert sichtbar gewordene Schäden, behandelt Einzelpersonen und trennt Ressorts, obwohl Ursachen oft außerhalb medizinischer Versorgung liegen. Dadurch entstehen Reparaturkosten, die in Haushalten sichtbar sind, während vermiedene Krankheit unsichtbar bleibt.

3. Wirkungsökonomischer Perspektivwechsel

Die Wirkungsökonomie fragt nach Zustandsveränderungen. Sie unterscheidet Behandlung, Prävention, Stabilisierung, Teilhabe, Autonomie und Resilienz. Ein Gesundheitsprogramm ist nicht erfolgreich, weil es viele Leistungen abrechnet, sondern weil es Gesundheitsrisiken senkt, Selbstständigkeit erhält, Versorgung verbessert und Vertrauen stärkt.

4. Wirkungspfade

Direkte Wirkung: bessere Versorgung, weniger Symptome, weniger Komplikationen, schnellere Hilfe.

Indirekte Wirkung: weniger Pflegebedarf, weniger Arbeitsausfälle, weniger Familienüberlastung, mehr Teilhabe.

Systemische Wirkung: weniger Reparaturkosten, höhere Resilienz, mehr Vertrauen, geringere Krisenanfälligkeit.

Demokratische Wirkung: Menschen erleben handlungsfähige Institutionen und gerechte Zugänge.

5. Indikatoren und WÖk-ID-Anschluss

Arbeits- und Gesundheitsschutz

psychosoziale Risiken

Lokale Emissionen NOx/PM/SOx

Gesunde Gebäude und Innenraumluft

Lärm-Exposition

Stadtgrün/Naturzugang

Produktsicherheit und Rückrufe

6. Datenquellen und Datenqualität

Datenart

Beispiel

Schutzanforderung

Strukturdaten

Versorgungsdichte, Wartezeiten, Pflegekapazität

keine personenbezogene Sanktionierung

Sozialraumdaten

Hitze, Lärm, Grün, Armut, Einsamkeitsrisiko

kommunale Transparenz und Kontext

Versorgungsdaten

Wiederaufnahmen, Prävention, Patientensicherheit

Zweckbindung, Datenschutz, Pseudonymisierung

Qualitative Daten

Würde, Autonomie, Belastung, Vertrauen

freiwillig, nicht diskriminierend

7. Berechnungs- und Bewertungslogik

Bewertung erfolgt mehrdimensional: Gesundheitsgewinn, vermiedener Schaden, Resilienz, Teilhabe, Gerechtigkeit, Datenqualität und Nebenwirkungen. Monetarisierung ist möglich, aber nicht allein entscheidend. Nicht alles, was zählt, lässt sich sofort in Euro ausdrücken; trotzdem muss es sichtbar bleiben.

8. Politische Umsetzungsoptionen

Politik kann verschiedene Wege wählen: gesetzliche Garantie, Kassenfinanzierung, kommunale Gesundheitsfonds, Modellregionen, öffentliche Beschaffung, Arbeitgeberpflichten oder Förderprogramme. Entscheidend ist nicht die eine Ideologie, sondern die Korrigierbarkeit und Überprüfbarkeit der Wirkung.

9. Grenzen und Missbrauchsschutz

Gesundheitswirkung darf nie zum Menschenranking werden. Bewertet werden Räume, Programme und Strukturen. Schutzgrenzen sind: keine Schuldlogik gegen Kranke, keine Diskriminierung, keine heimliche Gesundheitsüberwachung, kein Zugriff auf individuelle Gesundheitsdaten ohne Rechtsgrundlage und keine Verengung auf Selbstoptimierung.

11. Konkretes Beispiel

Beispielhaft wird ein Pilot mit 50.000 Einwohner:innen betrachtet. Ausgangsdaten: Gesundheitsausgaben, Pflegebedarf, Altersstruktur, Hitze- und Lärmbelastung, Versorgungszugang, Wartezeiten, soziale Lage und subjektive Belastung. Interventionen: Gesundheitslots:innen, Präventionsbudget, Pflegeentlastung, Sozialraumverbesserung und digitale Unterstützung. Die jährliche Evaluation misst nicht nur Leistungsmengen, sondern Zustandsveränderungen.

12. Rechenlogik für das Dossier

Zwei Bilanzen statt einer Mischrechnung: Euro gehören zu Euro. Lebensqualität, Autonomie, Teilhabe und Resilienz behalten ihre eigenen Einheiten. Beides zählt, wird aber nicht zu einer Zahl vermischt.

```
Monetäre Bilanz (EUR, Preisbasis und Zeitraum offenlegen): B_EUR = Summe_t [(vermiedene
Behandlungskosten_t + vermiedene Pflegekosten_t + monetarisierte Arbeitsausfälle_t + sonstige
dokumentiert monetarisierte Nutzen_t - Programmkosten_t - monetarisierte Nebenwirkungs- und
Verlagerungskosten_t) / (1 + r)^t]. Jeder Term ist Euro desselben Preisjahrs; r ist der
dokumentierte Diskontsatz. Fehlt eine belastbare Monetarisierung, darf der Term nicht in B_EUR
stehen.
```

Nichtmonetäres Wirkungsprofil: Für Gesundheitszustand, Autonomie, Teilhabe, Resilienz, Gerechtigkeit und mögliche Schäden wird je Indikator die Veränderung gegenüber dem Vergleichsfall ausgewiesen: Δx_k = x_k,mit Maßnahme - x_k,ohne Maßnahme. Jede Angabe braucht Einheit, Zeitraum, Quelle, Vergleichsfall, Attribution und Unsicherheit. Diese Veränderungen werden nicht in Euro umgerechnet und nicht zu einem Durchschnitt verrechnet.

Entscheidungsregel: Eine positive monetäre Bilanz ist kein Freifahrtschein. Eine positive Netto-Wirkung wird nur ausgewiesen, wenn Wirkungsgrenze, Vergleichsfall und Datenqualität offenliegen, keine rote Linie verletzt wird und das Wirkungsprofil keine schwere Verschlechterung verdeckt. Alle Angaben bleiben Quelle, Schätzung oder Modellwert.

Versorgungsräume, Kliniken und Gesundheitsnetzwerke

Versorgung wird von Sektorengrenzen auf integrierte Wirkungsräume umgestellt: ambulant, stationär, mobil, digital, psychisch, pflegerisch und kommunal.

1. Zielbild und Abgrenzung

Das Ziel ist nicht eine perfekt gesunde Normgesellschaft. Krankheit, Behinderung, Alter, Verletzlichkeit und Unterschiedlichkeit gehören zur menschlichen Wirklichkeit. Das Ziel ist ein System, das vermeidbare Gesundheitsrisiken reduziert, Zugang sichert, Würde schützt und positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie erzeugt.

2. Problem der alten Logik

Die alte Logik arbeitet reaktiv. Sie finanziert sichtbar gewordene Schäden, behandelt Einzelpersonen und trennt Ressorts, obwohl Ursachen oft außerhalb medizinischer Versorgung liegen. Dadurch entstehen Reparaturkosten, die in Haushalten sichtbar sind, während vermiedene Krankheit unsichtbar bleibt.

3. Wirkungsökonomischer Perspektivwechsel

Die Wirkungsökonomie fragt nach Zustandsveränderungen. Sie unterscheidet Behandlung, Prävention, Stabilisierung, Teilhabe, Autonomie und Resilienz. Ein Gesundheitsprogramm ist nicht erfolgreich, weil es viele Leistungen abrechnet, sondern weil es Gesundheitsrisiken senkt, Selbstständigkeit erhält, Versorgung verbessert und Vertrauen stärkt.

4. Wirkungspfade

Direkte Wirkung: bessere Versorgung, weniger Symptome, weniger Komplikationen, schnellere Hilfe.

Indirekte Wirkung: weniger Pflegebedarf, weniger Arbeitsausfälle, weniger Familienüberlastung, mehr Teilhabe.

Systemische Wirkung: weniger Reparaturkosten, höhere Resilienz, mehr Vertrauen, geringere Krisenanfälligkeit.

Demokratische Wirkung: Menschen erleben handlungsfähige Institutionen und gerechte Zugänge.

5. Indikatoren und WÖk-ID-Anschluss

Arbeits- und Gesundheitsschutz

psychosoziale Risiken

Lokale Emissionen NOx/PM/SOx

Gesunde Gebäude und Innenraumluft

Lärm-Exposition

Stadtgrün/Naturzugang

Produktsicherheit und Rückrufe

6. Datenquellen und Datenqualität

Datenart

Beispiel

Schutzanforderung

Strukturdaten

Versorgungsdichte, Wartezeiten, Pflegekapazität

keine personenbezogene Sanktionierung

Sozialraumdaten

Hitze, Lärm, Grün, Armut, Einsamkeitsrisiko

kommunale Transparenz und Kontext

Versorgungsdaten

Wiederaufnahmen, Prävention, Patientensicherheit

Zweckbindung, Datenschutz, Pseudonymisierung

Qualitative Daten

Würde, Autonomie, Belastung, Vertrauen

freiwillig, nicht diskriminierend

7. Berechnungs- und Bewertungslogik

Bewertung erfolgt mehrdimensional: Gesundheitsgewinn, vermiedener Schaden, Resilienz, Teilhabe, Gerechtigkeit, Datenqualität und Nebenwirkungen. Monetarisierung ist möglich, aber nicht allein entscheidend. Nicht alles, was zählt, lässt sich sofort in Euro ausdrücken; trotzdem muss es sichtbar bleiben.

8. Politische Umsetzungsoptionen

Politik kann verschiedene Wege wählen: gesetzliche Garantie, Kassenfinanzierung, kommunale Gesundheitsfonds, Modellregionen, öffentliche Beschaffung, Arbeitgeberpflichten oder Förderprogramme. Entscheidend ist nicht die eine Ideologie, sondern die Korrigierbarkeit und Überprüfbarkeit der Wirkung.

9. Grenzen und Missbrauchsschutz

Gesundheitswirkung darf nie zum Menschenranking werden. Bewertet werden Räume, Programme und Strukturen. Schutzgrenzen sind: keine Schuldlogik gegen Kranke, keine Diskriminierung, keine heimliche Gesundheitsüberwachung, kein Zugriff auf individuelle Gesundheitsdaten ohne Rechtsgrundlage und keine Verengung auf Selbstoptimierung.

11. Konkretes Beispiel

Beispielhaft wird ein Pilot mit 50.000 Einwohner:innen betrachtet. Ausgangsdaten: Gesundheitsausgaben, Pflegebedarf, Altersstruktur, Hitze- und Lärmbelastung, Versorgungszugang, Wartezeiten, soziale Lage und subjektive Belastung. Interventionen: Gesundheitslots:innen, Präventionsbudget, Pflegeentlastung, Sozialraumverbesserung und digitale Unterstützung. Die jährliche Evaluation misst nicht nur Leistungsmengen, sondern Zustandsveränderungen.

12. Rechenlogik für das Dossier

Zwei Bilanzen statt einer Mischrechnung: Euro gehören zu Euro. Lebensqualität, Autonomie, Teilhabe und Resilienz behalten ihre eigenen Einheiten. Beides zählt, wird aber nicht zu einer Zahl vermischt.

```
Monetäre Bilanz (EUR, Preisbasis und Zeitraum offenlegen): B_EUR = Summe_t [(vermiedene
Behandlungskosten_t + vermiedene Pflegekosten_t + monetarisierte Arbeitsausfälle_t + sonstige
dokumentiert monetarisierte Nutzen_t - Programmkosten_t - monetarisierte Nebenwirkungs- und
Verlagerungskosten_t) / (1 + r)^t]. Jeder Term ist Euro desselben Preisjahrs; r ist der
dokumentierte Diskontsatz. Fehlt eine belastbare Monetarisierung, darf der Term nicht in B_EUR
stehen.
```

Nichtmonetäres Wirkungsprofil: Für Gesundheitszustand, Autonomie, Teilhabe, Resilienz, Gerechtigkeit und mögliche Schäden wird je Indikator die Veränderung gegenüber dem Vergleichsfall ausgewiesen: Δx_k = x_k,mit Maßnahme - x_k,ohne Maßnahme. Jede Angabe braucht Einheit, Zeitraum, Quelle, Vergleichsfall, Attribution und Unsicherheit. Diese Veränderungen werden nicht in Euro umgerechnet und nicht zu einem Durchschnitt verrechnet.

Entscheidungsregel: Eine positive monetäre Bilanz ist kein Freifahrtschein. Eine positive Netto-Wirkung wird nur ausgewiesen, wenn Wirkungsgrenze, Vergleichsfall und Datenqualität offenliegen, keine rote Linie verletzt wird und das Wirkungsprofil keine schwere Verschlechterung verdeckt. Alle Angaben bleiben Quelle, Schätzung oder Modellwert.

Pflege als Wirkleistung und Pflegeökosystem

Pflege ist Beziehungs-, Würde- und Stabilitätsarbeit. Sie erhält Autonomie, entlastet Familien, verhindert Folgeschäden und braucht eine eigene Wirkungsarchitektur.

1. Zielbild und Abgrenzung

Das Ziel ist nicht eine perfekt gesunde Normgesellschaft. Krankheit, Behinderung, Alter, Verletzlichkeit und Unterschiedlichkeit gehören zur menschlichen Wirklichkeit. Das Ziel ist ein System, das vermeidbare Gesundheitsrisiken reduziert, Zugang sichert, Würde schützt und positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie erzeugt.

2. Problem der alten Logik

Die alte Logik arbeitet reaktiv. Sie finanziert sichtbar gewordene Schäden, behandelt Einzelpersonen und trennt Ressorts, obwohl Ursachen oft außerhalb medizinischer Versorgung liegen. Dadurch entstehen Reparaturkosten, die in Haushalten sichtbar sind, während vermiedene Krankheit unsichtbar bleibt.

3. Wirkungsökonomischer Perspektivwechsel

Die Wirkungsökonomie fragt nach Zustandsveränderungen. Sie unterscheidet Behandlung, Prävention, Stabilisierung, Teilhabe, Autonomie und Resilienz. Ein Gesundheitsprogramm ist nicht erfolgreich, weil es viele Leistungen abrechnet, sondern weil es Gesundheitsrisiken senkt, Selbstständigkeit erhält, Versorgung verbessert und Vertrauen stärkt.

4. Wirkungspfade

Direkte Wirkung: bessere Versorgung, weniger Symptome, weniger Komplikationen, schnellere Hilfe.

Indirekte Wirkung: weniger Pflegebedarf, weniger Arbeitsausfälle, weniger Familienüberlastung, mehr Teilhabe.

Systemische Wirkung: weniger Reparaturkosten, höhere Resilienz, mehr Vertrauen, geringere Krisenanfälligkeit.

Demokratische Wirkung: Menschen erleben handlungsfähige Institutionen und gerechte Zugänge.

5. Indikatoren und WÖk-ID-Anschluss

Arbeits- und Gesundheitsschutz

psychosoziale Risiken

Lokale Emissionen NOx/PM/SOx

Gesunde Gebäude und Innenraumluft

Lärm-Exposition

Stadtgrün/Naturzugang

Produktsicherheit und Rückrufe

6. Datenquellen und Datenqualität

Datenart

Beispiel

Schutzanforderung

Strukturdaten	
Versorgungsdichte, Wartezeiten, Pflegekapazität	
keine personenbezogene Sanktionierung	
Sozialraumdaten	
Hitze, Lärm, Grün, Armut, Einsamkeitsrisiko	
kommunale Transparenz und Kontext	
Versorgungsdaten	
Wiederaufnahmen, Prävention, Patientensicherheit	
Zweckbindung, Datenschutz, Pseudonymisierung	
Qualitative Daten	
Würde, Autonomie, Belastung, Vertrauen	
freiwillig, nicht diskriminierend	

7. Berechnungs- und Bewertungslogik

Bewertung erfolgt mehrdimensional: Gesundheitsgewinn, vermiedener Schaden, Resilienz, Teilhabe, Gerechtigkeit, Datenqualität und Nebenwirkungen. Monetarisierung ist möglich, aber nicht allein entscheidend. Nicht alles, was zählt, lässt sich sofort in Euro ausdrücken; trotzdem muss es sichtbar bleiben.

8. Politische Umsetzungsoptionen

Politik kann verschiedene Wege wählen: gesetzliche Garantie, Kassenfinanzierung, kommunale Gesundheitsfonds, Modellregionen, öffentliche Beschaffung, Arbeitgeberpflichten oder Förderprogramme. Entscheidend ist nicht die eine Ideologie, sondern die Korrigierbarkeit und Überprüfbarkeit der Wirkung.

9. Grenzen und Missbrauchsschutz

Gesundheitswirkung darf nie zum Menschenranking werden. Bewertet werden Räume, Programme und Strukturen. Schutzgrenzen sind: keine Schuldlogik gegen Kranke, keine Diskriminierung, keine heimliche Gesundheitsüberwachung, kein Zugriff auf individuelle Gesundheitsdaten ohne Rechtsgrundlage und keine Verengung auf Selbstoptimierung.

11. Konkretes Beispiel

Beispielhaft wird ein Pilot mit 50.000 Einwohner:innen betrachtet. Ausgangsdaten: Gesundheitsausgaben, Pflegebedarf, Altersstruktur, Hitze- und Lärmbelastung, Versorgungszugang, Wartezeiten, soziale Lage und subjektive Belastung. Interventionen: Gesundheitslots:innen, Präventionsbudget, Pflegeentlastung, Sozialraumverbesserung und digitale Unterstützung. Die jährliche Evaluation misst nicht nur Leistungsmengen, sondern Zustandsveränderungen.

12. Rechenlogik für das Dossier

Zwei Bilanzen statt einer Mischrechnung: Euro gehören zu Euro. Lebensqualität, Autonomie, Teilhabe und Resilienz behalten ihre eigenen Einheiten. Beides zählt, wird aber nicht zu einer Zahl vermischt.

```
Monetäre Bilanz (EUR, Preisbasis und Zeitraum offenlegen): B_EUR = Summe_t [(vermiedene
Behandlungskosten_t + vermiedene Pflegekosten_t + monetarisierte Arbeitsausfälle_t + sonstige
dokumentiert monetarisierte Nutzen_t - Programmkosten_t - monetarisierte Nebenwirkungs- und
Verlagerungskosten_t) / (1 + r)^t]. Jeder Term ist Euro desselben Preisjahrs; r ist der
dokumentierte Diskontsatz. Fehlt eine belastbare Monetarisierung, darf der Term nicht in B_EUR
stehen.
```

Nichtmonetäres Wirkungsprofil: Für Gesundheitszustand, Autonomie, Teilhabe, Resilienz, Gerechtigkeit und mögliche Schäden wird je Indikator die Veränderung gegenüber dem Vergleichsfall ausgewiesen: Δx_k = x_k,mit Maßnahme - x_k,ohne Maßnahme. Jede Angabe braucht Einheit, Zeitraum, Quelle, Vergleichsfall, Attribution und Unsicherheit. Diese Veränderungen werden nicht in Euro umgerechnet und nicht zu einem Durchschnitt verrechnet.

Entscheidungsregel: Eine positive monetäre Bilanz ist kein Freifahrtschein. Eine positive Netto-Wirkung wird nur ausgewiesen, wenn Wirkungsgrenze, Vergleichsfall und Datenqualität offenliegen, keine rote Linie verletzt wird und das Wirkungsprofil keine schwere Verschlechterung verdeckt. Alle Angaben bleiben Quelle, Schätzung oder Modellwert.

Psychische Gesundheit und soziale Stabilität

Psychische Gesundheit wird als Systembedingung von Demokratie, Arbeit, Bildung und sozialem Zusammenhalt gelesen. Einsamkeit, digitale Gewalt, Stress und Überforderung werden als Wirkungsrisiken sichtbar.

1. Zielbild und Abgrenzung

Das Ziel ist nicht eine perfekt gesunde Normgesellschaft. Krankheit, Behinderung, Alter, Verletzlichkeit und Unterschiedlichkeit gehören zur menschlichen Wirklichkeit. Das Ziel ist ein System, das vermeidbare Gesundheitsrisiken reduziert, Zugang sichert, Würde schützt und positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie erzeugt.

2. Problem der alten Logik

Die alte Logik arbeitet reaktiv. Sie finanziert sichtbar gewordene Schäden, behandelt Einzelpersonen und trennt Ressorts, obwohl Ursachen oft außerhalb medizinischer Versorgung liegen. Dadurch entstehen Reparaturkosten, die in Haushalten sichtbar sind, während vermiedene Krankheit unsichtbar bleibt.

3. Wirkungsökonomischer Perspektivwechsel

Die Wirkungsökonomie fragt nach Zustandsveränderungen. Sie unterscheidet Behandlung, Prävention, Stabilisierung, Teilhabe, Autonomie und Resilienz. Ein Gesundheitsprogramm ist nicht erfolgreich, weil es viele Leistungen abrechnet, sondern weil es Gesundheitsrisiken senkt, Selbstständigkeit erhält, Versorgung verbessert und Vertrauen stärkt.

4. Wirkungspfade

Direkte Wirkung: bessere Versorgung, weniger Symptome, weniger Komplikationen, schnellere Hilfe.

Indirekte Wirkung: weniger Pflegebedarf, weniger Arbeitsausfälle, weniger Familienüberlastung, mehr Teilhabe.

Systemische Wirkung: weniger Reparaturkosten, höhere Resilienz, mehr Vertrauen, geringere Krisenanfälligkeit.

Demokratische Wirkung: Menschen erleben handlungsfähige Institutionen und gerechte Zugänge.

5. Indikatoren und WÖk-ID-Anschluss

Arbeits- und Gesundheitsschutz

psychosoziale Risiken

Lokale Emissionen NOx/PM/SOx

Gesunde Gebäude und Innenraumluft

Lärm-Exposition

Stadtgrün/Naturzugang

Produktsicherheit und Rückrufe

6. Datenquellen und Datenqualität

Datenart

Beispiel

Schutzanforderung

Strukturdaten	
Versorgungsdichte, Wartezeiten, Pflegekapazität	
keine personenbezogene Sanktionierung	
Sozialraumdaten	
Hitze, Lärm, Grün, Armut, Einsamkeitsrisiko	
kommunale Transparenz und Kontext	
Versorgungsdaten	
Wiederaufnahmen, Prävention, Patientensicherheit	
Zweckbindung, Datenschutz, Pseudonymisierung	
Qualitative Daten	
Würde, Autonomie, Belastung, Vertrauen	
freiwillig, nicht diskriminierend	

7. Berechnungs- und Bewertungslogik

Bewertung erfolgt mehrdimensional: Gesundheitsgewinn, vermiedener Schaden, Resilienz, Teilhabe, Gerechtigkeit, Datenqualität und Nebenwirkungen. Monetarisierung ist möglich, aber nicht allein entscheidend. Nicht alles, was zählt, lässt sich sofort in Euro ausdrücken; trotzdem muss es sichtbar bleiben.

8. Politische Umsetzungsoptionen

Politik kann verschiedene Wege wählen: gesetzliche Garantie, Kassenfinanzierung, kommunale Gesundheitsfonds, Modellregionen, öffentliche Beschaffung, Arbeitgeberpflichten oder Förderprogramme. Entscheidend ist nicht die eine Ideologie, sondern die Korrigierbarkeit und Überprüfbarkeit der Wirkung.

9. Grenzen und Missbrauchsschutz

Gesundheitswirkung darf nie zum Menschenranking werden. Bewertet werden Räume, Programme und Strukturen. Schutzgrenzen sind: keine Schuldlogik gegen Kranke, keine Diskriminierung, keine heimliche Gesundheitsüberwachung, kein Zugriff auf individuelle Gesundheitsdaten ohne Rechtsgrundlage und keine Verengung auf Selbstoptimierung.

11. Konkretes Beispiel

Beispielhaft wird ein Pilot mit 50.000 Einwohner:innen betrachtet. Ausgangsdaten: Gesundheitsausgaben, Pflegebedarf, Altersstruktur, Hitze- und Lärmbelastung, Versorgungszugang, Wartezeiten, soziale Lage und subjektive Belastung. Interventionen: Gesundheitslots:innen, Präventionsbudget, Pflegeentlastung, Sozialraumverbesserung und digitale Unterstützung. Die jährliche Evaluation misst nicht nur Leistungsmengen, sondern Zustandsveränderungen.

12. Rechenlogik für das Dossier

Zwei Bilanzen statt einer Mischrechnung: Euro gehören zu Euro. Lebensqualität, Autonomie, Teilhabe und Resilienz behalten ihre eigenen Einheiten. Beides zählt, wird aber nicht zu einer Zahl vermischt.

```
Monetäre Bilanz (EUR, Preisbasis und Zeitraum offenlegen): B_EUR = Summe_t [(vermiedene
Behandlungskosten_t + vermiedene Pflegekosten_t + monetarisierte Arbeitsausfälle_t + sonstige
dokumentiert monetarisierte Nutzen_t - Programmkosten_t - monetarisierte Nebenwirkungs- und
Verlagerungskosten_t) / (1 + r)^t]. Jeder Term ist Euro desselben Preisjahrs; r ist der
dokumentierte Diskontsatz. Fehlt eine belastbare Monetarisierung, darf der Term nicht in B_EUR
stehen.
```

Nichtmonetäres Wirkungsprofil: Für Gesundheitszustand, Autonomie, Teilhabe, Resilienz, Gerechtigkeit und mögliche Schäden wird je Indikator die Veränderung gegenüber dem Vergleichsfall ausgewiesen: Δx_k = x_k,mit Maßnahme - x_k,ohne Maßnahme. Jede Angabe braucht Einheit, Zeitraum, Quelle, Vergleichsfall, Attribution und Unsicherheit. Diese Veränderungen werden nicht in Euro umgerechnet und nicht zu einem Durchschnitt verrechnet.

Entscheidungsregel: Eine positive monetäre Bilanz ist kein Freifahrtschein. Eine positive Netto-Wirkung wird nur ausgewiesen, wenn Wirkungsgrenze, Vergleichsfall und Datenqualität offenliegen, keine rote Linie verletzt wird und das Wirkungsprofil keine schwere Verschlechterung verdeckt. Alle Angaben bleiben Quelle, Schätzung oder Modellwert.

Gesundheitsgerechtigkeit, Inklusion und Migration

Gesundheitsgerechtigkeit heißt, vermeidbare und systematisch erzeugte Unterschiede nicht als privates Schicksal zu behandeln. Migration ist zugleich Versorgungsfaktor, Fachkräftefrage und Teilhabefrage.

1. Zielbild und Abgrenzung

Das Ziel ist nicht eine perfekt gesunde Normgesellschaft. Krankheit, Behinderung, Alter, Verletzlichkeit und Unterschiedlichkeit gehören zur menschlichen Wirklichkeit. Das Ziel ist ein System, das vermeidbare Gesundheitsrisiken reduziert, Zugang sichert, Würde schützt und positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie erzeugt.

2. Problem der alten Logik

Die alte Logik arbeitet reaktiv. Sie finanziert sichtbar gewordene Schäden, behandelt Einzelpersonen und trennt Ressorts, obwohl Ursachen oft außerhalb medizinischer Versorgung liegen. Dadurch entstehen Reparaturkosten, die in Haushalten sichtbar sind, während vermiedene Krankheit unsichtbar bleibt.

3. Wirkungsökonomischer Perspektivwechsel

Die Wirkungsökonomie fragt nach Zustandsveränderungen. Sie unterscheidet Behandlung, Prävention, Stabilisierung, Teilhabe, Autonomie und Resilienz. Ein Gesundheitsprogramm ist nicht erfolgreich, weil es viele Leistungen abrechnet, sondern weil es Gesundheitsrisiken senkt, Selbstständigkeit erhält, Versorgung verbessert und Vertrauen stärkt.

4. Wirkungspfade

Direkte Wirkung: bessere Versorgung, weniger Symptome, weniger Komplikationen, schnellere Hilfe.

Indirekte Wirkung: weniger Pflegebedarf, weniger Arbeitsausfälle, weniger Familienüberlastung, mehr Teilhabe.

Systemische Wirkung: weniger Reparaturkosten, höhere Resilienz, mehr Vertrauen, geringere Krisenanfälligkeit.

Demokratische Wirkung: Menschen erleben handlungsfähige Institutionen und gerechte Zugänge.

5. Indikatoren und WÖk-ID-Anschluss

Arbeits- und Gesundheitsschutz

psychosoziale Risiken

Lokale Emissionen NOx/PM/SOx

Gesunde Gebäude und Innenraumluft

Lärm-Exposition

Stadtgrün/Naturzugang

Produktsicherheit und Rückrufe

6. Datenquellen und Datenqualität

Datenart

Beispiel

Schutzanforderung

Strukturdaten	
Versorgungsdichte, Wartezeiten, Pflegekapazität	
keine personenbezogene Sanktionierung	
Sozialraumdaten	
Hitze, Lärm, Grün, Armut, Einsamkeitsrisiko	
kommunale Transparenz und Kontext	
Versorgungsdaten	
Wiederaufnahmen, Prävention, Patientensicherheit	
Zweckbindung, Datenschutz, Pseudonymisierung	
Qualitative Daten	
Würde, Autonomie, Belastung, Vertrauen	
freiwillig, nicht diskriminierend	

7. Berechnungs- und Bewertungslogik

Bewertung erfolgt mehrdimensional: Gesundheitsgewinn, vermiedener Schaden, Resilienz, Teilhabe, Gerechtigkeit, Datenqualität und Nebenwirkungen. Monetarisierung ist möglich, aber nicht allein entscheidend. Nicht alles, was zählt, lässt sich sofort in Euro ausdrücken; trotzdem muss es sichtbar bleiben.

8. Politische Umsetzungsoptionen

Politik kann verschiedene Wege wählen: gesetzliche Garantie, Kassenfinanzierung, kommunale Gesundheitsfonds, Modellregionen, öffentliche Beschaffung, Arbeitgeberpflichten oder Förderprogramme. Entscheidend ist nicht die eine Ideologie, sondern die Korrigierbarkeit und Überprüfbarkeit der Wirkung.

9. Grenzen und Missbrauchsschutz

Gesundheitswirkung darf nie zum Menschenranking werden. Bewertet werden Räume, Programme und Strukturen. Schutzgrenzen sind: keine Schuldlogik gegen Kranke, keine Diskriminierung, keine heimliche Gesundheitsüberwachung, kein Zugriff auf individuelle Gesundheitsdaten ohne Rechtsgrundlage und keine Verengung auf Selbstoptimierung.

11. Konkretes Beispiel

Beispielhaft wird ein Pilot mit 50.000 Einwohner:innen betrachtet. Ausgangsdaten: Gesundheitsausgaben, Pflegebedarf, Altersstruktur, Hitze- und Lärmbelastung, Versorgungszugang, Wartezeiten, soziale Lage und subjektive Belastung. Interventionen: Gesundheitslots:innen, Präventionsbudget, Pflegeentlastung, Sozialraumverbesserung und digitale Unterstützung. Die jährliche Evaluation misst nicht nur Leistungsmengen, sondern Zustandsveränderungen.

12. Rechenlogik für das Dossier

Zwei Bilanzen statt einer Mischrechnung: Euro gehören zu Euro. Lebensqualität, Autonomie, Teilhabe und Resilienz behalten ihre eigenen Einheiten. Beides zählt, wird aber nicht zu einer Zahl vermischt.

```
Monetäre Bilanz (EUR, Preisbasis und Zeitraum offenlegen): B_EUR = Summe_t [(vermiedene
Behandlungskosten_t + vermiedene Pflegekosten_t + monetarisierte Arbeitsausfälle_t + sonstige
dokumentiert monetarisierte Nutzen_t - Programmkosten_t - monetarisierte Nebenwirkungs- und
Verlagerungskosten_t) / (1 + r)^t]. Jeder Term ist Euro desselben Preisjahrs; r ist der
dokumentierte Diskontsatz. Fehlt eine belastbare Monetarisierung, darf der Term nicht in B_EUR
stehen.
```

Nichtmonetäres Wirkungsprofil: Für Gesundheitszustand, Autonomie, Teilhabe, Resilienz, Gerechtigkeit und mögliche Schäden wird je Indikator die Veränderung gegenüber dem Vergleichsfall ausgewiesen: Δx_k = x_k,mit Maßnahme - x_k,ohne Maßnahme. Jede Angabe braucht Einheit, Zeitraum, Quelle, Vergleichsfall, Attribution und Unsicherheit. Diese Veränderungen werden nicht in Euro umgerechnet und nicht zu einem Durchschnitt verrechnet.

Entscheidungsregel: Eine positive monetäre Bilanz ist kein Freifahrtschein. Eine positive Netto-Wirkung wird nur ausgewiesen, wenn Wirkungsgrenze, Vergleichsfall und Datenqualität offenliegen, keine rote Linie verletzt wird und das Wirkungsprofil keine schwere Verschlechterung verdeckt. Alle Angaben bleiben Quelle, Schätzung oder Modellwert.

One Health, Klima, Umwelt und Ernährung

Gesundheit ist planetar verbunden: Hitze, Luft, Wasser, Boden, Biodiversität, Ernährung, Chemikalien, Lärm und Naturzugang sind Gesundheitsfaktoren.

1. Zielbild und Abgrenzung

Das Ziel ist nicht eine perfekt gesunde Normgesellschaft. Krankheit, Behinderung, Alter, Verletzlichkeit und Unterschiedlichkeit gehören zur menschlichen Wirklichkeit. Das Ziel ist ein System, das vermeidbare Gesundheitsrisiken reduziert, Zugang sichert, Würde schützt und positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie erzeugt.

2. Problem der alten Logik

Die alte Logik arbeitet reaktiv. Sie finanziert sichtbar gewordene Schäden, behandelt Einzelpersonen und trennt Ressorts, obwohl Ursachen oft außerhalb medizinischer Versorgung liegen. Dadurch entstehen Reparaturkosten, die in Haushalten sichtbar sind, während vermiedene Krankheit unsichtbar bleibt.

3. Wirkungsökonomischer Perspektivwechsel

Die Wirkungsökonomie fragt nach Zustandsveränderungen. Sie unterscheidet Behandlung, Prävention, Stabilisierung, Teilhabe, Autonomie und Resilienz. Ein Gesundheitsprogramm ist nicht erfolgreich, weil es viele Leistungen abrechnet, sondern weil es Gesundheitsrisiken senkt, Selbstständigkeit erhält, Versorgung verbessert und Vertrauen stärkt.

4. Wirkungspfade

Direkte Wirkung: bessere Versorgung, weniger Symptome, weniger Komplikationen, schnellere Hilfe.

Indirekte Wirkung: weniger Pflegebedarf, weniger Arbeitsausfälle, weniger Familienüberlastung, mehr Teilhabe.

Systemische Wirkung: weniger Reparaturkosten, höhere Resilienz, mehr Vertrauen, geringere Krisenanfälligkeit.

Demokratische Wirkung: Menschen erleben handlungsfähige Institutionen und gerechte Zugänge.

5. Indikatoren und WÖk-ID-Anschluss

Arbeits- und Gesundheitsschutz

psychosoziale Risiken

Lokale Emissionen NOx/PM/SOx

Gesunde Gebäude und Innenraumluft

Lärm-Exposition

Stadtgrün/Naturzugang

Produktsicherheit und Rückrufe

6. Datenquellen und Datenqualität

Datenart

Beispiel

Schutzanforderung

Strukturdaten

Versorgungsdichte, Wartezeiten, Pflegekapazität

keine personenbezogene Sanktionierung

Sozialraumdaten

Hitze, Lärm, Grün, Armut, Einsamkeitsrisiko

kommunale Transparenz und Kontext

Versorgungsdaten

Wiederaufnahmen, Prävention, Patientensicherheit

Zweckbindung, Datenschutz, Pseudonymisierung

Qualitative Daten

Würde, Autonomie, Belastung, Vertrauen

freiwillig, nicht diskriminierend

7. Berechnungs- und Bewertungslogik

Bewertung erfolgt mehrdimensional: Gesundheitsgewinn, vermiedener Schaden, Resilienz, Teilhabe, Gerechtigkeit, Datenqualität und Nebenwirkungen. Monetarisierung ist möglich, aber nicht allein entscheidend. Nicht alles, was zählt, lässt sich sofort in Euro ausdrücken; trotzdem muss es sichtbar bleiben.

8. Politische Umsetzungsoptionen

Politik kann verschiedene Wege wählen: gesetzliche Garantie, Kassenfinanzierung, kommunale Gesundheitsfonds, Modellregionen, öffentliche Beschaffung, Arbeitgeberpflichten oder Förderprogramme. Entscheidend ist nicht die eine Ideologie, sondern die Korrigierbarkeit und Überprüfbarkeit der Wirkung.

9. Grenzen und Missbrauchsschutz

Gesundheitswirkung darf nie zum Menschenranking werden. Bewertet werden Räume, Programme und Strukturen. Schutzgrenzen sind: keine Schuldlogik gegen Kranke, keine Diskriminierung, keine heimliche Gesundheitsüberwachung, kein Zugriff auf individuelle Gesundheitsdaten ohne Rechtsgrundlage und keine Verengung auf Selbstoptimierung.

11. Konkretes Beispiel

Beispielhaft wird ein Pilot mit 50.000 Einwohner:innen betrachtet. Ausgangsdaten: Gesundheitsausgaben, Pflegebedarf, Altersstruktur, Hitze- und Lärmbelastung, Versorgungszugang, Wartezeiten, soziale Lage und subjektive Belastung. Interventionen: Gesundheitslots:innen, Präventionsbudget, Pflegeentlastung, Sozialraumverbesserung und digitale Unterstützung. Die jährliche Evaluation misst nicht nur Leistungsmengen, sondern Zustandsveränderungen.

12. Rechenlogik für das Dossier

Zwei Bilanzen statt einer Mischrechnung: Euro gehören zu Euro. Lebensqualität, Autonomie, Teilhabe und Resilienz behalten ihre eigenen Einheiten. Beides zählt, wird aber nicht zu einer Zahl vermischt.

```
Monetäre Bilanz (EUR, Preisbasis und Zeitraum offenlegen): B_EUR = Summe_t [(vermiedene
Behandlungskosten_t + vermiedene Pflegekosten_t + monetarisierte Arbeitsausfälle_t + sonstige
dokumentiert monetarisierte Nutzen_t - Programmkosten_t - monetarisierte Nebenwirkungs- und
Verlagerungskosten_t) / (1 + r)^t]. Jeder Term ist Euro desselben Preisjahrs; r ist der
dokumentierte Diskontsatz. Fehlt eine belastbare Monetarisierung, darf der Term nicht in B_EUR
stehen.
```

Nichtmonetäres Wirkungsprofil: Für Gesundheitszustand, Autonomie, Teilhabe, Resilienz, Gerechtigkeit und mögliche Schäden wird je Indikator die Veränderung gegenüber dem Vergleichsfall ausgewiesen: Δx_k = x_k,mit Maßnahme - x_k,ohne Maßnahme. Jede Angabe braucht Einheit, Zeitraum, Quelle, Vergleichsfall, Attribution und Unsicherheit. Diese Veränderungen werden nicht in Euro umgerechnet und nicht zu einem Durchschnitt verrechnet.

Entscheidungsregel: Eine positive monetäre Bilanz ist kein Freifahrtschein. Eine positive Netto-Wirkung wird nur ausgewiesen, wenn Wirkungsgrenze, Vergleichsfall und Datenqualität offenliegen, keine rote Linie verletzt wird und das Wirkungsprofil keine schwere Verschlechterung verdeckt. Alle Angaben bleiben Quelle, Schätzung oder Modellwert.

Arbeitswelt, Unternehmen und Gesundheitswirkung

Arbeit ist Gesundheitsraum. Führung, Arbeitszeit, KI-Druck, Schichtsysteme, Sicherheit, Anerkennung und Beteiligung wirken auf Körper und Psyche.

1. Zielbild und Abgrenzung

Das Ziel ist nicht eine perfekt gesunde Normgesellschaft. Krankheit, Behinderung, Alter, Verletzlichkeit und Unterschiedlichkeit gehören zur menschlichen Wirklichkeit. Das Ziel ist ein System, das vermeidbare Gesundheitsrisiken reduziert, Zugang sichert, Würde schützt und positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie erzeugt.

2. Problem der alten Logik

Die alte Logik arbeitet reaktiv. Sie finanziert sichtbar gewordene Schäden, behandelt Einzelpersonen und trennt Ressorts, obwohl Ursachen oft außerhalb medizinischer Versorgung liegen. Dadurch entstehen Reparaturkosten, die in Haushalten sichtbar sind, während vermiedene Krankheit unsichtbar bleibt.

3. Wirkungsökonomischer Perspektivwechsel

Die Wirkungsökonomie fragt nach Zustandsveränderungen. Sie unterscheidet Behandlung, Prävention, Stabilisierung, Teilhabe, Autonomie und Resilienz. Ein Gesundheitsprogramm ist nicht erfolgreich, weil es viele Leistungen abrechnet, sondern weil es Gesundheitsrisiken senkt, Selbstständigkeit erhält, Versorgung verbessert und Vertrauen stärkt.

4. Wirkungspfade

Direkte Wirkung: bessere Versorgung, weniger Symptome, weniger Komplikationen, schnellere Hilfe.

Indirekte Wirkung: weniger Pflegebedarf, weniger Arbeitsausfälle, weniger Familienüberlastung, mehr Teilhabe.

Systemische Wirkung: weniger Reparaturkosten, höhere Resilienz, mehr Vertrauen, geringere Krisenanfälligkeit.

Demokratische Wirkung: Menschen erleben handlungsfähige Institutionen und gerechte Zugänge.

5. Indikatoren und WÖk-ID-Anschluss

Arbeits- und Gesundheitsschutz

psychosoziale Risiken

Lokale Emissionen NOx/PM/SOx

Gesunde Gebäude und Innenraumluft

Lärm-Exposition

Stadtgrün/Naturzugang

Produktsicherheit und Rückrufe

6. Datenquellen und Datenqualität

Datenart

Beispiel

Schutzanforderung

Strukturdaten	
Versorgungsdichte, Wartezeiten, Pflegekapazität	
keine personenbezogene Sanktionierung	
Sozialraumdaten	
Hitze, Lärm, Grün, Armut, Einsamkeitsrisiko	
kommunale Transparenz und Kontext	
Versorgungsdaten	
Wiederaufnahmen, Prävention, Patientensicherheit	
Zweckbindung, Datenschutz, Pseudonymisierung	
Qualitative Daten	
Würde, Autonomie, Belastung, Vertrauen	
freiwillig, nicht diskriminierend	

7. Berechnungs- und Bewertungslogik

Bewertung erfolgt mehrdimensional: Gesundheitsgewinn, vermiedener Schaden, Resilienz, Teilhabe, Gerechtigkeit, Datenqualität und Nebenwirkungen. Monetarisierung ist möglich, aber nicht allein entscheidend. Nicht alles, was zählt, lässt sich sofort in Euro ausdrücken; trotzdem muss es sichtbar bleiben.

8. Politische Umsetzungsoptionen

Politik kann verschiedene Wege wählen: gesetzliche Garantie, Kassenfinanzierung, kommunale Gesundheitsfonds, Modellregionen, öffentliche Beschaffung, Arbeitgeberpflichten oder Förderprogramme. Entscheidend ist nicht die eine Ideologie, sondern die Korrigierbarkeit und Überprüfbarkeit der Wirkung.

9. Grenzen und Missbrauchsschutz

Gesundheitswirkung darf nie zum Menschenranking werden. Bewertet werden Räume, Programme und Strukturen. Schutzgrenzen sind: keine Schuldlogik gegen Kranke, keine Diskriminierung, keine heimliche Gesundheitsüberwachung, kein Zugriff auf individuelle Gesundheitsdaten ohne Rechtsgrundlage und keine Verengung auf Selbstoptimierung.

11. Konkretes Beispiel

Beispielhaft wird ein Pilot mit 50.000 Einwohner:innen betrachtet. Ausgangsdaten: Gesundheitsausgaben, Pflegebedarf, Altersstruktur, Hitze- und Lärmbelastung, Versorgungszugang, Wartezeiten, soziale Lage und subjektive Belastung. Interventionen: Gesundheitslots:innen, Präventionsbudget, Pflegeentlastung, Sozialraumverbesserung und digitale Unterstützung. Die jährliche Evaluation misst nicht nur Leistungsmengen, sondern Zustandsveränderungen.

12. Rechenlogik für das Dossier

Zwei Bilanzen statt einer Mischrechnung: Euro gehören zu Euro. Lebensqualität, Autonomie, Teilhabe und Resilienz behalten ihre eigenen Einheiten. Beides zählt, wird aber nicht zu einer Zahl vermischt.

```
Monetäre Bilanz (EUR, Preisbasis und Zeitraum offenlegen): B_EUR = Summe_t [(vermiedene
Behandlungskosten_t + vermiedene Pflegekosten_t + monetarisierte Arbeitsausfälle_t + sonstige
dokumentiert monetarisierte Nutzen_t - Programmkosten_t - monetarisierte Nebenwirkungs- und
Verlagerungskosten_t) / (1 + r)^t]. Jeder Term ist Euro desselben Preisjahrs; r ist der
dokumentierte Diskontsatz. Fehlt eine belastbare Monetarisierung, darf der Term nicht in B_EUR
stehen.
```

Nichtmonetäres Wirkungsprofil: Für Gesundheitszustand, Autonomie, Teilhabe, Resilienz, Gerechtigkeit und mögliche Schäden wird je Indikator die Veränderung gegenüber dem Vergleichsfall ausgewiesen: Δx_k = x_k,mit Maßnahme - x_k,ohne Maßnahme. Jede Angabe braucht Einheit, Zeitraum, Quelle, Vergleichsfall, Attribution und Unsicherheit. Diese Veränderungen werden nicht in Euro umgerechnet und nicht zu einem Durchschnitt verrechnet.

Entscheidungsregel: Eine positive monetäre Bilanz ist kein Freifahrtschein. Eine positive Netto-Wirkung wird nur ausgewiesen, wenn Wirkungsgrenze, Vergleichsfall und Datenqualität offenliegen, keine rote Linie verletzt wird und das Wirkungsprofil keine schwere Verschlechterung verdeckt. Alle Angaben bleiben Quelle, Schätzung oder Modellwert.

Gesundheitsdaten, KI und Bürgerkontrolle

Daten können Frühwarnung, Versorgung und Prävention verbessern, müssen aber gemeinwohlgebunden, transparent, sicher und unter Bürgerkontrolle bleiben.

1. Zielbild und Abgrenzung

Das Ziel ist nicht eine perfekt gesunde Normgesellschaft. Krankheit, Behinderung, Alter, Verletzlichkeit und Unterschiedlichkeit gehören zur menschlichen Wirklichkeit. Das Ziel ist ein System, das vermeidbare Gesundheitsrisiken reduziert, Zugang sichert, Würde schützt und positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie erzeugt.

2. Problem der alten Logik

Die alte Logik arbeitet reaktiv. Sie finanziert sichtbar gewordene Schäden, behandelt Einzelpersonen und trennt Ressorts, obwohl Ursachen oft außerhalb medizinischer Versorgung liegen. Dadurch entstehen Reparaturkosten, die in Haushalten sichtbar sind, während vermiedene Krankheit unsichtbar bleibt.

3. Wirkungsökonomischer Perspektivwechsel

Die Wirkungsökonomie fragt nach Zustandsveränderungen. Sie unterscheidet Behandlung, Prävention, Stabilisierung, Teilhabe, Autonomie und Resilienz. Ein Gesundheitsprogramm ist nicht erfolgreich, weil es viele Leistungen abrechnet, sondern weil es Gesundheitsrisiken senkt, Selbstständigkeit erhält, Versorgung verbessert und Vertrauen stärkt.

4. Wirkungspfade

Direkte Wirkung: bessere Versorgung, weniger Symptome, weniger Komplikationen, schnellere Hilfe.

Indirekte Wirkung: weniger Pflegebedarf, weniger Arbeitsausfälle, weniger Familienüberlastung, mehr Teilhabe.

Systemische Wirkung: weniger Reparaturkosten, höhere Resilienz, mehr Vertrauen, geringere Krisenanfälligkeit.

Demokratische Wirkung: Menschen erleben handlungsfähige Institutionen und gerechte Zugänge.

5. Indikatoren und WÖk-ID-Anschluss

Arbeits- und Gesundheitsschutz

psychosoziale Risiken

Lokale Emissionen NOx/PM/SOx

Gesunde Gebäude und Innenraumluft

Lärm-Exposition

Stadtgrün/Naturzugang

Produktsicherheit und Rückrufe

6. Datenquellen und Datenqualität

Datenart

Beispiel

Schutzanforderung

Strukturdaten	
Versorgungsdichte, Wartezeiten, Pflegekapazität	
keine personenbezogene Sanktionierung	
Sozialraumdaten	
Hitze, Lärm, Grün, Armut, Einsamkeitsrisiko	
kommunale Transparenz und Kontext	
Versorgungsdaten	
Wiederaufnahmen, Prävention, Patientensicherheit	
Zweckbindung, Datenschutz, Pseudonymisierung	
Qualitative Daten	
Würde, Autonomie, Belastung, Vertrauen	
freiwillig, nicht diskriminierend	

7. Berechnungs- und Bewertungslogik

Bewertung erfolgt mehrdimensional: Gesundheitsgewinn, vermiedener Schaden, Resilienz, Teilhabe, Gerechtigkeit, Datenqualität und Nebenwirkungen. Monetarisierung ist möglich, aber nicht allein entscheidend. Nicht alles, was zählt, lässt sich sofort in Euro ausdrücken; trotzdem muss es sichtbar bleiben.

8. Politische Umsetzungsoptionen

Politik kann verschiedene Wege wählen: gesetzliche Garantie, Kassenfinanzierung, kommunale Gesundheitsfonds, Modellregionen, öffentliche Beschaffung, Arbeitgeberpflichten oder Förderprogramme. Entscheidend ist nicht die eine Ideologie, sondern die Korrigierbarkeit und Überprüfbarkeit der Wirkung.

9. Grenzen und Missbrauchsschutz

Gesundheitswirkung darf nie zum Menschenranking werden. Bewertet werden Räume, Programme und Strukturen. Schutzgrenzen sind: keine Schuldlogik gegen Kranke, keine Diskriminierung, keine heimliche Gesundheitsüberwachung, kein Zugriff auf individuelle Gesundheitsdaten ohne Rechtsgrundlage und keine Verengung auf Selbstoptimierung.

11. Konkretes Beispiel

Beispielhaft wird ein Pilot mit 50.000 Einwohner:innen betrachtet. Ausgangsdaten: Gesundheitsausgaben, Pflegebedarf, Altersstruktur, Hitze- und Lärmbelastung, Versorgungszugang, Wartezeiten, soziale Lage und subjektive Belastung. Interventionen: Gesundheitslots:innen, Präventionsbudget, Pflegeentlastung, Sozialraumverbesserung und digitale Unterstützung. Die jährliche Evaluation misst nicht nur Leistungsmengen, sondern Zustandsveränderungen.

12. Rechenlogik für das Dossier

Zwei Bilanzen statt einer Mischrechnung: Euro gehören zu Euro. Lebensqualität, Autonomie, Teilhabe und Resilienz behalten ihre eigenen Einheiten. Beides zählt, wird aber nicht zu einer Zahl vermischt.

```
Monetäre Bilanz (EUR, Preisbasis und Zeitraum offenlegen): B_EUR = Summe_t [(vermiedene
Behandlungskosten_t + vermiedene Pflegekosten_t + monetarisierte Arbeitsausfälle_t + sonstige
dokumentiert monetarisierte Nutzen_t - Programmkosten_t - monetarisierte Nebenwirkungs- und
Verlagerungskosten_t) / (1 + r)^t]. Jeder Term ist Euro desselben Preisjahrs; r ist der
dokumentierte Diskontsatz. Fehlt eine belastbare Monetarisierung, darf der Term nicht in B_EUR
stehen.
```

Nichtmonetäres Wirkungsprofil: Für Gesundheitszustand, Autonomie, Teilhabe, Resilienz, Gerechtigkeit und mögliche Schäden wird je Indikator die Veränderung gegenüber dem Vergleichsfall ausgewiesen: Δx_k = x_k,mit Maßnahme - x_k,ohne Maßnahme. Jede Angabe braucht Einheit, Zeitraum, Quelle, Vergleichsfall, Attribution und Unsicherheit. Diese Veränderungen werden nicht in Euro umgerechnet und nicht zu einem Durchschnitt verrechnet.

Entscheidungsregel: Eine positive monetäre Bilanz ist kein Freifahrtschein. Eine positive Netto-Wirkung wird nur ausgewiesen, wenn Wirkungsgrenze, Vergleichsfall und Datenqualität offenliegen, keine rote Linie verletzt wird und das Wirkungsprofil keine schwere Verschlechterung verdeckt. Alle Angaben bleiben Quelle, Schätzung oder Modellwert.

Finanzierung, Wirkungsfonds und Gesundheitskassen

Finanzierung wird von Reparatur auf Wirkung verschoben: Präventionsfonds, Gesundheitskassen, Pflegeentlastungsfonds und Wirkungshaushalte machen verhinderte Schäden sichtbar.

1. Zielbild und Abgrenzung

Das Ziel ist nicht eine perfekt gesunde Normgesellschaft. Krankheit, Behinderung, Alter, Verletzlichkeit und Unterschiedlichkeit gehören zur menschlichen Wirklichkeit. Das Ziel ist ein System, das vermeidbare Gesundheitsrisiken reduziert, Zugang sichert, Würde schützt und positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie erzeugt.

2. Problem der alten Logik

Die alte Logik arbeitet reaktiv. Sie finanziert sichtbar gewordene Schäden, behandelt Einzelpersonen und trennt Ressorts, obwohl Ursachen oft außerhalb medizinischer Versorgung liegen. Dadurch entstehen Reparaturkosten, die in Haushalten sichtbar sind, während vermiedene Krankheit unsichtbar bleibt.

3. Wirkungsökonomischer Perspektivwechsel

Die Wirkungsökonomie fragt nach Zustandsveränderungen. Sie unterscheidet Behandlung, Prävention, Stabilisierung, Teilhabe, Autonomie und Resilienz. Ein Gesundheitsprogramm ist nicht erfolgreich, weil es viele Leistungen abrechnet, sondern weil es Gesundheitsrisiken senkt, Selbstständigkeit erhält, Versorgung verbessert und Vertrauen stärkt.

4. Wirkungspfade

Direkte Wirkung: bessere Versorgung, weniger Symptome, weniger Komplikationen, schnellere Hilfe.

Indirekte Wirkung: weniger Pflegebedarf, weniger Arbeitsausfälle, weniger Familienüberlastung, mehr Teilhabe.

Systemische Wirkung: weniger Reparaturkosten, höhere Resilienz, mehr Vertrauen, geringere Krisenanfälligkeit.

Demokratische Wirkung: Menschen erleben handlungsfähige Institutionen und gerechte Zugänge.

5. Indikatoren und WÖk-ID-Anschluss

Arbeits- und Gesundheitsschutz

psychosoziale Risiken

Lokale Emissionen NOx/PM/SOx

Gesunde Gebäude und Innenraumluft

Lärm-Exposition

Stadtgrün/Naturzugang

Produktsicherheit und Rückrufe

6. Datenquellen und Datenqualität

Datenart

Beispiel

Schutzanforderung

Strukturdaten

Versorgungsdichte, Wartezeiten, Pflegekapazität

keine personenbezogene Sanktionierung

Sozialraumdaten

Hitze, Lärm, Grün, Armut, Einsamkeitsrisiko

kommunale Transparenz und Kontext

Versorgungsdaten

Wiederaufnahmen, Prävention, Patientensicherheit

Zweckbindung, Datenschutz, Pseudonymisierung

Qualitative Daten

Würde, Autonomie, Belastung, Vertrauen

freiwillig, nicht diskriminierend

7. Berechnungs- und Bewertungslogik

Bewertung erfolgt mehrdimensional: Gesundheitsgewinn, vermiedener Schaden, Resilienz, Teilhabe, Gerechtigkeit, Datenqualität und Nebenwirkungen. Monetarisierung ist möglich, aber nicht allein entscheidend. Nicht alles, was zählt, lässt sich sofort in Euro ausdrücken; trotzdem muss es sichtbar bleiben.

8. Politische Umsetzungsoptionen

Politik kann verschiedene Wege wählen: gesetzliche Garantie, Kassenfinanzierung, kommunale Gesundheitsfonds, Modellregionen, öffentliche Beschaffung, Arbeitgeberpflichten oder Förderprogramme. Entscheidend ist nicht die eine Ideologie, sondern die Korrigierbarkeit und Überprüfbarkeit der Wirkung.

9. Grenzen und Missbrauchsschutz

Gesundheitswirkung darf nie zum Menschenranking werden. Bewertet werden Räume, Programme und Strukturen. Schutzgrenzen sind: keine Schuldlogik gegen Kranke, keine Diskriminierung, keine heimliche Gesundheitsüberwachung, kein Zugriff auf individuelle Gesundheitsdaten ohne Rechtsgrundlage und keine Verengung auf Selbstoptimierung.

11. Konkretes Beispiel

Beispielhaft wird ein Pilot mit 50.000 Einwohner:innen betrachtet. Ausgangsdaten: Gesundheitsausgaben, Pflegebedarf, Altersstruktur, Hitze- und Lärmbelastung, Versorgungszugang, Wartezeiten, soziale Lage und subjektive Belastung. Interventionen: Gesundheitslots:innen, Präventionsbudget, Pflegeentlastung, Sozialraumverbesserung und digitale Unterstützung. Die jährliche Evaluation misst nicht nur Leistungsmengen, sondern Zustandsveränderungen.

12. Rechenlogik für das Dossier

Zwei Bilanzen statt einer Mischrechnung: Euro gehören zu Euro. Lebensqualität, Autonomie, Teilhabe und Resilienz behalten ihre eigenen Einheiten. Beides zählt, wird aber nicht zu einer Zahl vermischt.

```
Monetäre Bilanz (EUR, Preisbasis und Zeitraum offenlegen): B_EUR = Summe_t [(vermiedene Behandlungskosten_t + vermiedene Pflegekosten_t + monetarisierte Arbeitsausfälle_t + sonstige dokumentiert monetarisierte Nutzen_t - Programmkosten_t - monetarisierte Nebenwirkungs- und Verlagerungskosten_t) / (1 + r)^t]. Jeder Term ist Euro desselben Preisjahrs; r ist der dokumentierte Diskontsatz. Fehlt eine belastbare Monetarisierung, darf der Term nicht in B_EUR stehen.
```

Nichtmonetäres Wirkungsprofil: Für Gesundheitszustand, Autonomie, Teilhabe, Resilienz, Gerechtigkeit und mögliche Schäden wird je Indikator die Veränderung gegenüber dem Vergleichsfall ausgewiesen: Δx_k = x_k,mit Maßnahme - x_k,ohne Maßnahme. Jede Angabe braucht Einheit, Zeitraum, Quelle, Vergleichsfall, Attribution und Unsicherheit. Diese Veränderungen werden nicht in Euro umgerechnet und nicht zu einem Durchschnitt verrechnet.

Entscheidungsregel: Eine positive monetäre Bilanz ist kein Freifahrtschein. Eine positive Netto-Wirkung wird nur ausgewiesen, wenn Wirkungsgrenze, Vergleichsfall und Datenqualität offenliegen, keine rote Linie verletzt wird und das Wirkungsprofil keine schwere Verschlechterung verdeckt. Alle Angaben bleiben Quelle, Schätzung oder Modellwert.

Versorgung, Kliniken und Gesundheitsnetzwerke

Kliniken bleiben wichtig, werden aber nicht allein nach Fallzahlen gesteuert. Vorhaltung, Qualität, Koordination, Übergänge und Prävention werden Teil der Wirkungslogik.

1. Zielbild und Abgrenzung

Das Ziel ist nicht eine perfekt gesunde Normgesellschaft. Krankheit, Behinderung, Alter, Verletzlichkeit und Unterschiedlichkeit gehören zur menschlichen Wirklichkeit. Das Ziel ist ein System, das vermeidbare Gesundheitsrisiken reduziert, Zugang sichert, Würde schützt und positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie erzeugt.

2. Problem der alten Logik

Die alte Logik arbeitet reaktiv. Sie finanziert sichtbar gewordene Schäden, behandelt Einzelpersonen und trennt Ressorts, obwohl Ursachen oft außerhalb medizinischer Versorgung liegen. Dadurch entstehen Reparaturkosten, die in Haushalten sichtbar sind, während vermiedene Krankheit unsichtbar bleibt.

3. Wirkungsökonomischer Perspektivwechsel

Die Wirkungsökonomie fragt nach Zustandsveränderungen. Sie unterscheidet Behandlung, Prävention, Stabilisierung, Teilhabe, Autonomie und Resilienz. Ein Gesundheitsprogramm ist nicht erfolgreich, weil es viele Leistungen abrechnet, sondern weil es Gesundheitsrisiken senkt, Selbstständigkeit erhält, Versorgung verbessert und Vertrauen stärkt.

4. Wirkungspfade

Direkte Wirkung: bessere Versorgung, weniger Symptome, weniger Komplikationen, schnellere Hilfe.

Indirekte Wirkung: weniger Pflegebedarf, weniger Arbeitsausfälle, weniger Familienüberlastung, mehr Teilhabe.

Systemische Wirkung: weniger Reparaturkosten, höhere Resilienz, mehr Vertrauen, geringere Krisenanfälligkeit.

Demokratische Wirkung: Menschen erleben handlungsfähige Institutionen und gerechte Zugänge.

5. Indikatoren und WÖk-ID-Anschluss

Arbeits- und Gesundheitsschutz

psychosoziale Risiken

Lokale Emissionen NOx/PM/SOx

Gesunde Gebäude und Innenraumluft

Lärm-Exposition

Stadtgrün/Naturzugang

Produktsicherheit und Rückrufe

6. Datenquellen und Datenqualität

Datenart

Beispiel

Schutzanforderung

Strukturdaten

Versorgungsdichte, Wartezeiten, Pflegekapazität

keine personenbezogene Sanktionierung

Sozialraumdaten

Hitze, Lärm, Grün, Armut, Einsamkeitsrisiko

kommunale Transparenz und Kontext

Versorgungsdaten

Wiederaufnahmen, Prävention, Patientensicherheit

Zweckbindung, Datenschutz, Pseudonymisierung

Qualitative Daten

Würde, Autonomie, Belastung, Vertrauen

freiwillig, nicht diskriminierend

7. Berechnungs- und Bewertungslogik

Bewertung erfolgt mehrdimensional: Gesundheitsgewinn, vermiedener Schaden, Resilienz, Teilhabe, Gerechtigkeit, Datenqualität und Nebenwirkungen. Monetarisierung ist möglich, aber nicht allein entscheidend. Nicht alles, was zählt, lässt sich sofort in Euro ausdrücken; trotzdem muss es sichtbar bleiben.

8. Politische Umsetzungsoptionen

Politik kann verschiedene Wege wählen: gesetzliche Garantie, Kassenfinanzierung, kommunale Gesundheitsfonds, Modellregionen, öffentliche Beschaffung, Arbeitgeberpflichten oder Förderprogramme. Entscheidend ist nicht die eine Ideologie, sondern die Korrigierbarkeit und Überprüfbarkeit der Wirkung.

9. Grenzen und Missbrauchsschutz

Gesundheitswirkung darf nie zum Menschenranking werden. Bewertet werden Räume, Programme und Strukturen. Schutzgrenzen sind: keine Schuldlogik gegen Kranke, keine Diskriminierung, keine heimliche Gesundheitsüberwachung, kein Zugriff auf individuelle Gesundheitsdaten ohne Rechtsgrundlage und keine Verengung auf Selbstoptimierung.

11. Konkretes Beispiel

Beispielhaft wird ein Pilot mit 50.000 Einwohner:innen betrachtet. Ausgangsdaten: Gesundheitsausgaben, Pflegebedarf, Altersstruktur, Hitze- und Lärmbelastung, Versorgungszugang, Wartezeiten, soziale Lage und subjektive Belastung. Interventionen: Gesundheitslots:innen, Präventionsbudget, Pflegeentlastung, Sozialraumverbesserung und digitale Unterstützung. Die jährliche Evaluation misst nicht nur Leistungsmengen, sondern Zustandsveränderungen.

12. Rechenlogik für das Dossier

Zwei Bilanzen statt einer Mischrechnung: Euro gehören zu Euro. Lebensqualität, Autonomie, Teilhabe und Resilienz behalten ihre eigenen Einheiten. Beides zählt, wird aber nicht zu einer Zahl vermischt.

```
Monetäre Bilanz (EUR, Preisbasis und Zeitraum offenlegen): B_EUR = Summe_t [(vermiedene Behandlungskosten_t + vermiedene Pflegekosten_t + monetarisierte Arbeitsausfälle_t + sonstige dokumentiert monetarisierte Nutzen_t - Programmkosten_t - monetarisierte Nebenwirkungs- und Verlagerungskosten_t) / (1 + r)^t]. Jeder Term ist Euro desselben Preisjahrs; r ist der dokumentierte Diskontsatz. Fehlt eine belastbare Monetarisierung, darf der Term nicht in B_EUR stehen.
```

Nichtmonetäres Wirkungsprofil: Für Gesundheitszustand, Autonomie, Teilhabe, Resilienz, Gerechtigkeit und mögliche Schäden wird je Indikator die Veränderung gegenüber dem Vergleichsfall ausgewiesen: Δx_k = x_k,mit Maßnahme - x_k,ohne Maßnahme. Jede Angabe braucht Einheit, Zeitraum, Quelle, Vergleichsfall, Attribution und Unsicherheit. Diese Veränderungen werden nicht in Euro umgerechnet und nicht zu einem Durchschnitt verrechnet.

Entscheidungsregel: Eine positive monetäre Bilanz ist kein Freifahrtschein. Eine positive Netto-Wirkung wird nur ausgewiesen, wenn Wirkungsgrenze, Vergleichsfall und Datenqualität offenliegen, keine rote Linie verletzt wird und das Wirkungsprofil keine schwere Verschlechterung verdeckt. Alle Angaben bleiben Quelle, Schätzung oder Modellwert.

Governance, Wirkungsrat und politische Anschlussfähigkeit

Gesundheitspolitik bleibt demokratischer Aushandlungsraum. Die WÖk definiert Rahmen, Indikatoren, Schutzgrenzen und Korrekturverfahren, aber keinen Parteibeschluss.

1. Zielbild und Abgrenzung

Das Ziel ist nicht eine perfekt gesunde Normgesellschaft. Krankheit, Behinderung, Alter, Verletzlichkeit und Unterschiedlichkeit gehören zur menschlichen Wirklichkeit. Das Ziel ist ein System, das vermeidbare Gesundheitsrisiken reduziert, Zugang sichert, Würde schützt und positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie erzeugt.

2. Problem der alten Logik

Die alte Logik arbeitet reaktiv. Sie finanziert sichtbar gewordene Schäden, behandelt Einzelpersonen und trennt Ressorts, obwohl Ursachen oft außerhalb medizinischer Versorgung liegen. Dadurch entstehen Reparaturkosten, die in Haushalten sichtbar sind, während vermiedene Krankheit unsichtbar bleibt.

3. Wirkungsökonomischer Perspektivwechsel

Die Wirkungsökonomie fragt nach Zustandsveränderungen. Sie unterscheidet Behandlung, Prävention, Stabilisierung, Teilhabe, Autonomie und Resilienz. Ein Gesundheitsprogramm ist nicht erfolgreich, weil es viele Leistungen abrechnet, sondern weil es Gesundheitsrisiken senkt, Selbstständigkeit erhält, Versorgung verbessert und Vertrauen stärkt.

4. Wirkungspfade

Direkte Wirkung: bessere Versorgung, weniger Symptome, weniger Komplikationen, schnellere Hilfe.

Indirekte Wirkung: weniger Pflegebedarf, weniger Arbeitsausfälle, weniger Familienüberlastung, mehr Teilhabe.

Systemische Wirkung: weniger Reparaturkosten, höhere Resilienz, mehr Vertrauen, geringere Krisenanfälligkeit.

Demokratische Wirkung: Menschen erleben handlungsfähige Institutionen und gerechte Zugänge.

5. Indikatoren und WÖk-ID-Anschluss

Arbeits- und Gesundheitsschutz

psychosoziale Risiken

Lokale Emissionen NOx/PM/SOx

Gesunde Gebäude und Innenraumluft

Lärm-Exposition

Stadtgrün/Naturzugang

Produktsicherheit und Rückrufe

6. Datenquellen und Datenqualität

Datenart

Beispiel

Schutzanforderung

Strukturdaten

Versorgungsdichte, Wartezeiten, Pflegekapazität

keine personenbezogene Sanktionierung

Sozialraumdaten

Hitze, Lärm, Grün, Armut, Einsamkeitsrisiko

kommunale Transparenz und Kontext

Versorgungsdaten

Wiederaufnahmen, Prävention, Patientensicherheit

Zweckbindung, Datenschutz, Pseudonymisierung

Qualitative Daten

Würde, Autonomie, Belastung, Vertrauen

freiwillig, nicht diskriminierend

7. Berechnungs- und Bewertungslogik

Bewertung erfolgt mehrdimensional: Gesundheitsgewinn, vermiedener Schaden, Resilienz, Teilhabe, Gerechtigkeit, Datenqualität und Nebenwirkungen. Monetarisierung ist möglich, aber nicht allein entscheidend. Nicht alles, was zählt, lässt sich sofort in Euro ausdrücken; trotzdem muss es sichtbar bleiben.

8. Politische Umsetzungsoptionen

Politik kann verschiedene Wege wählen: gesetzliche Garantie, Kassenfinanzierung, kommunale Gesundheitsfonds, Modellregionen, öffentliche Beschaffung, Arbeitgeberpflichten oder Förderprogramme. Entscheidend ist nicht die eine Ideologie, sondern die Korrigierbarkeit und Überprüfbarkeit der Wirkung.

9. Grenzen und Missbrauchsschutz

Gesundheitswirkung darf nie zum Menschenranking werden. Bewertet werden Räume, Programme und Strukturen. Schutzgrenzen sind: keine Schuldlogik gegen Kranke, keine Diskriminierung, keine heimliche Gesundheitsüberwachung, kein Zugriff auf individuelle Gesundheitsdaten ohne Rechtsgrundlage und keine Verengung auf Selbstoptimierung.

11. Konkretes Beispiel

Beispielhaft wird ein Pilot mit 50.000 Einwohner:innen betrachtet. Ausgangsdaten: Gesundheitsausgaben, Pflegebedarf, Altersstruktur, Hitze- und Lärmbelastung, Versorgungszugang, Wartezeiten, soziale Lage und subjektive Belastung. Interventionen: Gesundheitslots:innen, Präventionsbudget, Pflegeentlastung, Sozialraumverbesserung und digitale Unterstützung. Die jährliche Evaluation misst nicht nur Leistungsmengen, sondern Zustandsveränderungen.

12. Rechenlogik für das Dossier

Zwei Bilanzen statt einer Mischrechnung: Euro gehören zu Euro. Lebensqualität, Autonomie, Teilhabe und Resilienz behalten ihre eigenen Einheiten. Beides zählt, wird aber nicht zu einer Zahl vermischt.

```
Monetäre Bilanz (EUR, Preisbasis und Zeitraum offenlegen): B_EUR = Summe_t [(vermiedene
Behandlungskosten_t + vermiedene Pflegekosten_t + monetarisierte Arbeitsausfälle_t + sonstige
dokumentiert monetarisierte Nutzen_t - Programmkosten_t - monetarisierte Nebenwirkungs- und
Verlagerungskosten_t) / (1 + r)^t]. Jeder Term ist Euro desselben Preisjahrs; r ist der
dokumentierte Diskontsatz. Fehlt eine belastbare Monetarisierung, darf der Term nicht in B_EUR
stehen.
```

Nichtmonetäres Wirkungsprofil: Für Gesundheitszustand, Autonomie, Teilhabe, Resilienz, Gerechtigkeit und mögliche Schäden wird je Indikator die Veränderung gegenüber dem Vergleichsfall ausgewiesen: Δx_k = x_k,mit Maßnahme - x_k,ohne Maßnahme. Jede Angabe braucht Einheit, Zeitraum, Quelle, Vergleichsfall, Attribution und Unsicherheit. Diese Veränderungen werden nicht in Euro umgerechnet und nicht zu einem Durchschnitt verrechnet.

Entscheidungsregel: Eine positive monetäre Bilanz ist kein Freifahrtschein. Eine positive Netto-Wirkung wird nur ausgewiesen, wenn Wirkungsgrenze, Vergleichsfall und Datenqualität offenliegen, keine rote Linie verletzt wird und das Wirkungsprofil keine schwere Verschlechterung verdeckt. Alle Angaben bleiben Quelle, Schätzung oder Modellwert.

Quellen und Anschlussdokumente

Natalie Weber: Die neue Ordnung des Wohlstands, Arbeitsfassung 2026, Kapitel 68 Gesundheit und Kapitel 69 Pflege.

Natalie Weber: Systemmodell der Wirkungsökonomie, Spalte 7 Gesundheit, Pflege & Leben.

Natalie Weber: Führender Begriffsleitfaden der Wirkungsökonomie v1.3.

WHO Constitution und WHO Social Determinants of Health, 2025.

OECD Health at a Glance 2025 - Germany.

Destatis: Gesundheitsausgaben und Pflegebedürftigkeit.

EU-Kommission: European Health Data Space Regulation.

BMG: Krankenhausreform und Pflegekompetenzgesetz.

Quellen zum Rechenweg

- T-SROI-Rechenstandard v1.1 und Quellenarchiv WÖK-Q-1024
- WHO: Social determinants of health
- OECD: Health at a Glance 2025
- Destatis: Gesundheitsausgaben
- Europäische Kommission: European Health Data Space
- Bundesministerium für Gesundheit: Gesundheitsberichterstattung und Monitoring

Diese externen Quellen begründen Daten- und Bezugsrahmen. Die konkrete Zwei-Bilanzen-Logik bleibt ein transparent gekennzeichnetes WÖk-Modell; sie ersetzt weder medizinische Diagnostik noch individuelle oder demokratische Entscheidungen.